Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Tympanoplastie

Réparation du tympan (associée si nécessaire à une réparation des osselets de l'oreille moyenne et à une mastoïdectomie)

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Côté : ☐ Droit ☐ Gauche

Visualisation : ☐ Microscopique ☐ Endoscopique ☐ À déterminer pendant l'intervention _____

Voie d'abord : ☐ Transcanalaire ☐ Rétro-auriculaire ☐ Endaurale _____

Origine de la greffe : ☐ Aponévrose musculaire (fascia temporal) ☐ Cartilage / périchondre ☐ Autre _____

Réparation des osselets (ossiculoplastie) : ☐ Non prévue ☐ Prévue ☐ Si nécessaire _____

Mastoïdectomie : ☐ Non prévue ☐ Prévue ☐ Si nécessaire _____

Date et résumé du test auditif préopératoire (audiogramme) : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

Le tympan est une fine membrane qui sépare le conduit auditif de l'oreille moyenne et transmet les vibrations sonores aux minuscules os (osselets) de l'oreille moyenne. Lorsque le tympan présente un **trou (perforation)**, l'audition diminue et l'eau ou les germes qui pénètrent dans l'oreille provoquent des **écoulements d'oreille à répétition**.

Les perforations du tympan sont le plus souvent dues à une **infection chronique de l'oreille moyenne**, et parfois à un traumatisme (une gifle, un coton-tige, une variation brutale de pression). Les petites perforations récentes peuvent se refermer d'elles-mêmes ; en revanche, les perforations anciennes ne se referment généralement pas. Chez

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

certains patients, l'infection peut également avoir usé les osselets de l'oreille moyenne ou s'être étendue aux cellules aériennes de l'os situé derrière l'oreille (mastoïde). En présence d'un **cholestéatome** dans l'oreille moyenne (un sac de cellules cutanées qui grossit et érode l'os), son traitement est particulièrement important.

L'objectif de la tympanoplastie est de refermer le tympan, de débarrasser l'oreille moyenne de l'infection afin d'obtenir une **oreille sèche et sûre** et, dans la mesure du possible, de **préserver ou d'améliorer l'audition**.

2 Comment se déroule l'intervention ?

L'intervention est réalisée sous anesthésie générale, au bloc opératoire, à l'aide d'un microscope et/ou d'un endoscope.

1. **Voie d'abord :** si la perforation est petite et bien située, l'intervention peut être réalisée entièrement par le conduit auditif, sans laisser de cicatrice visible. Pour les perforations plus grandes ou lorsqu'une vision plus large est nécessaire, une petite incision est faite derrière l'oreille (dans le pli situé derrière le pavillon) ou devant l'oreille.
2. **Prélèvement de la greffe :** les propres tissus du patient sont utilisés pour réparer le tympan : généralement l'enveloppe du muscle situé au-dessus de l'oreille (fascia temporal) ou le cartilage du pavillon de l'oreille et sa membrane de revêtement. Ces tissus sont prélevés par la même incision ou par une petite incision supplémentaire.
3. **Nettoyage de l'oreille moyenne :** les bords de la perforation sont avivés, le tympan est soulevé et l'oreille moyenne est examinée ; les éventuels tissus infectés et adhérences sont retirés. Les osselets sont vérifiés.
4. **Réparation des osselets (si nécessaire) :** si la chaîne des osselets est érodée ou interrompue, elle peut être reconstruite à l'aide d'un os/cartilage du patient ou d'une prothèse bien tolérée par les tissus, en titane par exemple.
5. **Mastoïdectomie (si nécessaire) :** si l'infection ou le cholestéatome s'est étendu aux cellules aériennes de l'os situé derrière l'oreille, ces cellules sont ouvertes et nettoyées à l'aide d'une fraise spéciale.
6. **Mise en place de la greffe et fermeture :** la greffe est placée sous ou sur la perforation. L'oreille moyenne et le conduit auditif sont soutenus par des éponges résorbables. Une éventuelle incision est refermée par des points de suture et un pansement compressif est appliqué sur l'oreille.

Si un cholestéatome est découvert, une **seconde intervention de contrôle (« second look ») 6–12 mois plus tard** peut être prévue chez certains patients afin de s'assurer que la maladie a été complètement retirée. Cela vous sera expliqué séparément.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie générale	Environ 1,5–3 heures (plus longtemps en cas de mastoïdectomie)	Généralement sortie le jour même ou 1 nuit

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Fermeture de la perforation du tympan
- Diminution ou disparition des épisodes d'écoulement et d'infection de l'oreille ; une oreille sèche et sûre
- Moins de précautions nécessaires pour protéger l'oreille lors du bain, de la douche et de la baignade
- Préservation ou amélioration de l'audition chez les patients pour lesquels cela est possible
- En cas de cholestéatome, retrait de la maladie et prévention de ses éventuelles complications graves

Une fermeture définitive du tympan est obtenue chez environ **85–95 %** des patients. L'amélioration de l'audition dépend de l'état des osselets, de l'étendue de l'infection et de l'état de l'oreille interne ; l'audition peut s'améliorer nettement, rester inchangée ou, rarement, se dégrader. Si la greffe ne prend pas ou si une nouvelle perforation se forme, l'intervention peut être renouvelée.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

4 Autres options thérapeutiques

- **Surveillance et maintien de l'oreille au sec :** pour les petites perforations sèches, des contrôles réguliers et la protection de l'oreille contre l'eau peuvent être une option. La perforation reste ouverte et le risque d'infection persiste.
- **Traitement médical :** les gouttes auriculaires antibiotiques contrôlent temporairement l'infection lors des épisodes d'écoulement ; elles ne referment pas la perforation.
- **Appareil auditif :** peut compenser la perte auditive ; il peut toutefois être difficile à utiliser sur une oreille qui coule et il ne referme pas la perforation.
- **Simple obturation des petites perforations :** pour les très petites perforations, une fermeture par un patch en papier ou par de la graisse (myringoplastie) peut être envisagée.

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Sans intervention, la perforation du tympan reste généralement ouverte. Les écoulements peuvent récidiver lorsque de l'eau pénètre dans l'oreille ou lors de rhumes, et la perte auditive peut s'aggraver avec le temps. En présence d'un cholestéatome non traité, celui-ci continue de grossir et peut entraîner des complications graves telles qu'une **perte auditive définitive, des vertiges, une paralysie faciale, une méningite ou un abcès cérébral**.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Un test auditif (audiogramme) est réalisé avant l'intervention et, si nécessaire, un scanner. Vous serez évalué(e) par le médecin anesthésiste.
- Vous ne devez rien manger ni boire pendant les **6–8 heures** précédant l'intervention (veuillez suivre les consignes du médecin anesthésiste).
- Si l'oreille coule activement, il pourra vous être demandé d'utiliser des gouttes avant l'intervention afin d'assécher l'oreille.
- Le jour de l'intervention, quelques cheveux derrière l'oreille peuvent être coupés. En cas de grippe ou d'infection respiratoire, l'intervention peut être reportée.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Premières 24–48 heures	Vous ressentirez une sensation de plénitude, une légère douleur et une impression d'oreille bouchée ; la douleur est soulagée par les antalgiques. De brefs vertiges légers et des nausées peuvent survenir. Le pansement compressif est généralement retiré le 1er jour. Évitez de vous coucher sur l'oreille opérée.
Semaines 1–2	

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	En raison des éponges présentes dans le conduit auditif, l'audition vous semblera **diminuée** pendant cette période ; c'est normal. Un léger écoulement teinté de sang peut sortir de l'oreille. Les points de suture sont généralement retirés entre le **7e et le 10e jour**. La plupart des personnes reprennent un travail de bureau en 1 semaine.
Semaines 3–6	Les éponges du conduit auditif sont retirées lors des contrôles ou se résorbent d'elles-mêmes. L'eau ne doit pas pénétrer dans l'oreille. Le sport intense, le port de charges lourdes et les efforts de poussée doivent être reportés pendant environ **4–6 semaines**. Le voyage en avion est généralement possible **après 2–4 semaines**, avec l'accord de votre médecin.
Mois 2–3	La prise de la greffe est évaluée lors des contrôles. Un test auditif réalisé à ce stade montre l'effet de l'intervention sur l'audition. La natation et le contact de l'oreille avec l'eau sont généralement autorisés après accord de votre médecin.
Mois 6–12	Le tympan et l'oreille moyenne achèvent leur cicatrisation. Après une chirurgie de cholestéatome, des contrôles réguliers et, si nécessaire, une imagerie ou une seconde intervention de contrôle sont prévus.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Sensation de plénitude et d'oreille bouchée, et impression d'audition diminuée au cours des premières semaines (due aux éponges dans le conduit auditif)
- Légère douleur d'oreille, craquements, bruits de liquide ou bourdonnements
- Léger écoulement teinté de sang par l'oreille (premiers jours)
- Engourdissement temporaire du pavillon de l'oreille et autour de l'incision ; oreille légèrement décollée (après une voie d'abord rétro-auriculaire ; cela se corrige en quelques semaines)

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Modification du goût** — Le nerf du goût (corde du tympan) passe juste derrière le tympan et peut être étiré pendant l'intervention ou, rarement, devoir être sectionné. Environ **5–20 patients sur 100** remarquent, de ce côté de la langue, un goût métallique ou une diminution du goût, ou une sensation de bouche sèche ; cela **s'améliore ou devient imperceptible en quelques semaines à quelques mois** dans la plupart des cas. Rarement, cela peut être définitif.
- **Acouphènes (sifflements dans l'oreille)** — Des sifflements dans l'oreille peuvent apparaître après l'intervention, ou des sifflements préexistants peuvent augmenter pendant un certain temps ; ils sont généralement temporaires.
- **Vertiges temporaires** — Une légère instabilité ou des vertiges peuvent survenir au cours des premiers jours ; ils disparaissent généralement en quelques jours.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Situations peu fréquentes

- **Échec de la greffe ou nouvelle perforation** — Chez environ **5–15 patients sur 100**, le tympan peut ne pas se refermer complètement ou une perforation peut se reformer ultérieurement. Dans ce cas, les écoulements peuvent persister et **l'intervention peut devoir être renouvelée**.
- **Absence d'amélioration de l'audition** — Même si le tympan se referme, l'audition peut ne pas s'améliorer comme prévu en raison de l'état des osselets, de la ventilation de l'oreille moyenne ou de l'oreille interne. Après une réparation des osselets, la prothèse peut se déplacer ou être expulsée à travers le tympan ; une nouvelle intervention peut être nécessaire.
- **Infection et écoulement de l'oreille** — Un écoulement de l'oreille ou une infection de la plaie peuvent survenir après l'intervention ; ils guérissent généralement avec des gouttes ou des antibiotiques. L'infection du cartilage du pavillon (périchondrite) est rare mais peut laisser une déformation du cartilage.
- **Rétrécissement du conduit auditif ou latéralisation du tympan** — Du tissu cicatriciel peut rétrécir le conduit auditif, ou le nouveau tympan peut s'éloigner de sa position normale ; cela peut affecter l'audition et nécessiter une intervention correctrice.
- **Récidive ou cholestéatome résiduel** — Après une chirurgie de cholestéatome, la maladie peut récidiver ou un petit résidu peut grossir chez certains patients ; un suivi à long terme et, si nécessaire, une **nouvelle intervention** sont donc indispensables.
- **Problèmes de plaie et de cicatrice** — Une cicatrice épaissie ou chéloïde au niveau de l'incision rétro-auriculaire et, rarement, une collection de liquide derrière l'oreille peuvent survenir.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Perte auditive définitive due à une atteinte de l'oreille interne** — Chez **moins de 1 patient sur 100**, une **surdité de perception définitive** peut survenir en raison d'une atteinte de l'oreille interne ; très rarement, l'audition de l'oreille opérée peut être totalement perdue (cophose, ou « oreille morte »). Cela peut nécessiter un appareil auditif ou une réhabilitation auditive plus poussée. Le risque est plus élevé en cas de cholestéatome et de maladie proche de l'oreille interne.
- **Vertiges et troubles de l'équilibre prolongés** — Rarement, l'oreille interne peut être atteinte, provoquant des vertiges qui durent plusieurs semaines ; des exercices d'équilibre et un traitement médicamenteux peuvent être nécessaires.
- **Paralysie du nerf facial** — Le nerf facial passant par l'oreille moyenne, très rarement (**bien moins de 1 patient sur 100**) une faiblesse temporaire ou définitive peut apparaître de ce côté du visage. Le risque est plus élevé en cas de cholestéatome, de réinterventions et de nerfs ayant un trajet inhabituel de naissance. Si elle survient, un traitement médicamenteux, une protection de l'œil et, si nécessaire, une chirurgie (décompression ou réparation du nerf) peuvent être nécessaires. Si elle est définitive, une asymétrie du visage et une fermeture incomplète de l'œil peuvent persister, nécessitant une protection oculaire à long terme et éventuellement une chirurgie de réanimation faciale.
- **Complications touchant les méninges** — En particulier lors d'une mastoïdectomie et d'une chirurgie de cholestéatome, lorsque l'os de la base du crâne s'est aminci, une fuite de liquide céphalo-rachidien (LCR), une méningite ou une lésion des méninges peuvent très rarement survenir. Cela peut nécessiter un traitement complémentaire à l'hôpital (parfois en réanimation) et une intervention chirurgicale ; une méningite peut rarement laisser des séquelles durables.
- **Modification définitive de la forme de l'oreille** — En raison de la voie d'abord rétro-auriculaire ou du prélèvement d'une greffe de cartilage, une légère modification de la position ou de la forme du pavillon de l'oreille peut rarement être définitive.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.
- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Perte auditive brutale et marquée** (une aggravation soudaine, différente de la sensation d'oreille bouchée due aux éponges)
- **Vertiges intenses**, vomissements et impossibilité de tenir debout
- **Faiblesse du visage** : affaissement du coin de la bouche, impossibilité de fermer l'œil
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C**, douleur d'oreille croissante, rougeur et gonflement du pavillon, ou écoulement purulent malodorant
- **Écoulement clair et aqueux** par l'oreille, maux de tête violents ou raideur de la nuque
- **Saignement qui ne s'arrête pas** au niveau du pansement ou de l'oreille

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Tant que votre médecin ne l'a pas autorisé, **ne laissez pas d'eau pénétrer dans votre oreille** : sous la douche, bouchez l'oreille avec du coton enduit de vaseline ; n'allez ni à la piscine ni à la mer.
- **Ne vous mouchez pas** pendant les **4–6 premières semaines** ; si vous devez éternuer, éternuez la bouche ouverte. Ne vous pincez pas le nez pour pousser (ne faites pas de manœuvre de Valsalva).
- Évitez de porter des charges lourdes, les efforts de poussée, de vous pencher et le sport intense au cours des premières semaines. Informez votre médecin si vous êtes constipé(e).

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Demandez toujours l'accord de votre médecin pour les voyages en avion, la plongée et les activités impliquant des variations de pression ; la **plongée** nécessite généralement un délai plus long.
- N'introduisez pas de coton-tige ni aucun autre objet dans le conduit auditif ; utilisez les gouttes auriculaires qui vous ont été prescrites comme indiqué.
- Si vous venez de l'étranger, planifiez votre voyage de retour avec votre médecin ; les contrôles et les tests auditifs après votre retour peuvent être poursuivis auprès d'un médecin ORL de votre pays.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

- ☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.
- ☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ Je comprends que l'objectif principal de l'intervention est de refermer le tympan et d'obtenir une oreille sèche et sûre ; que l'amélioration de l'audition ne peut pas être garantie et que, rarement, l'audition peut se dégrader.
- ☐ Il m'a été expliqué que, selon ce qui sera constaté pendant l'intervention, une réparation des osselets ou une mastoïdectomie peuvent être nécessaires, et je consens à ce que ces gestes soient réalisés comme indiqué ci-dessus.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien avec le patient :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.